PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA

COMARCA DE CAJAZEIRAS

JUIZADO ESPECIAL MISTO

Processo nº 0800312-46.2020.8.15.0131

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

AUTOR: KARLA SUYLLA TRAVASSOS GUEDES

REU: UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SENTENÇA

1. Relatório.

(Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95).

2. Fundamentação.

O processo transcorreu com absoluto respeito às normas legais e constitucionais, oportunizando-se ampla defesa e o contraditório. Não há vícios procedimentais a serem sanados.

A parte promovente narra que é usuária do plano de saúde fornecido pela parte promovida, sendo-lhe negado o fornecimento de fármaco essencial à manutenção de sua gravidez

2.Mérito.

Inexistem preliminares ou prejudiciais a serem apreciadas, ainda que de ofício, reputo o feito livre de vícios procedimentais. O processo encontra-se maduro para julgamento sendo inteiramente dispensável a produção de provas em audiência para a apreciação do mérito.

A parte autora alega sofrer de abortamento habitual, colacionando inclusive aborto anterior em decorrência de tal enfermidade, conforme indicado no relatório médico, anexo à inicial, e, por tal motivo, requer o fornecimento do medicamento Enoxaparina sódica 40 mg durante toda a gravidez e durante o período puerperal. A parte autora é usuária do plano de saúde junto à parte promovida, UNIVIDA ESPECIAL PLUS I COLETIVO EMPRESARIAL – Plano Ambulatorial + hospitalar com obstetrícia, solicitou a medicação, a que lhe fora concedido, mas da segunda solicitação foi negado, sob o argumento de que não possui cobertura contratual. Assim, diante da negativa de fornecimento do fármaco e do risco iminente de morte fetal, adquiriu a medicação suficiente para cerca de dois meses e ingressou com a presente ação. A tutela de urgência fora deferida.

Inicialmente, tem-se que o direito à saúde foi expressamente contemplado no artigo 196 da Constituição Federal. Nesta senda, o tema, o C. Supremo Tribunal Federal, ao interpretar os artigos 5º,caput, e 196 da Constituição Federal, consagrou o direito à saúde como consequência indissociável do direito à vida, assegurando a todas as pessoas, como se infere do julgamento do ARE 685.230/MS.

Nesta esteira, no caso em análise, o cerne da lide consiste no fornecimento de fármaco necessário à manutenção de gravidez por plano se saúde, o que envolve necessariamente análise do contrato do plano de saúde, responsabilidade deste frente a tal obrigação.

O plano de saúde alega que há cláusula expressa de exclusão de medicação de uso domiciliar, tal qual o solicitado pela parte promovente. Ora, a parte promovente no afã de resguardar sua saúde e de seu bebê contrata um plano de saúde que contempla tratamento ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, é forçoso concluir que medicamento indispensável à manutenção da gravidez e, consequentemente, da vida fetal está incluído pelo seguro-saúde.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os planos de saúde têm o dever de custear o tratamento de seus usuários quando há prescrição por médico, cuja especialidade é objeto da cobertura contratual. No caso em comento o plano engloba obstetrícia, o plano de saúde deve fornecer medicamento indispensável à manutenção da gravidez, ao passo que a parte promovente é acometida de trombofilia cuja consequência clínica, nos termos do laudo médico, é o abortamento, caso não seja ministrado a medicação indicada, inclusive a promovente já sofre aborto em decorrência da mesma enfermidade e data anterior, conforme laudos colacionados à exordial.

Ademais, em que pese existir tal exclusão contratual, há tendência na jurisprudência pátria de afastamento de cláusula contratual expressa que exclui fornecimento de medicamento domiciliar quando o plano engloba cobertura da doença/procedimento/especialidade, por evidente abusividade. Neste sentido, importante colacionar os seguintes julgados do STJ:

> SEGURO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DO

PROCEDIMENTO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO PRESCRITO NÃO POSSUI PREVISÃO NO ROL DA ANS. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA, TODAVIA, QUE VEM SE ORIENTANDO FIRMEMENTE NO SENTIDO DO RECONHECIMENTO DO CARÁTER ABUSIVO DAS CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA N.º 102 DO TJSP. REEMBOLSO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1054684-12.2019.8.26.0576; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 02/09/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. **PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CLÁUSULA ABUSIVA**. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL. RECUSA INJUSTIFICADA. CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. **O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano**. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. 3. A alteração das premissas firmadas no acórdão recorrido, de que o medicamento pleiteado pelo recorrido não se trata de medicamento experimental, exigiria reexame do conjunto probatório dos autos, providência vedada no recurso especial pela Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1055443/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. QUIMIOTERAPIA. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. É abusiva a recusa em conferir cobertura securitária para indenizar o valor de medicamento necessário ao restabelecimento da saúde do segurado, acometido com câncer.

2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no AREsp 548.161/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 08/06/2015).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. MEDICAÇÃO ESPECÍFICA. **IBRANCE - PALBOCICLIBE**. **PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA.** FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO. **DEVER DE COBERTURA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ CONTRATUAL. DANO MORAL EXISTENTE.** SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese, a demandante pretende compelir a ré a fornecer o medicamento Ibrance-Palbociclibe, por ter sido diagnosticada com neoplasia maligna de mama e metástase pulmonar. 2. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. 3. A Lei nº 9.656/1998, que regula a atividade desenvolvida pelos planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê a possibilidade de exclusão de cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar. Ressalva, no entanto, a cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, que é justamente o caso do uso do medicamento pleiteado pela autora. 3.1. Nesse contexto, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, no exercício do seu poder regulamentar, editou a Resolução Normativa nº 428/2017, por meio da qual permitiu a exclusão de cobertura do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, com exceção dos fármacos antineoplásicos orais. 4. É atribuição do profissional médico a decisão a respeito do medicamento adequado ao tratamento do paciente, não podendo haver interferência por parte da administradora de Plano de Saúde a esse respeito. 5. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo médico não se compatibiliza com o critério da boa-fé objetiva e com a legítima expectativa do paciente por ocasião da contratação do plano de saúde. 6**. Diante das circunstâncias concretamente examinadas, a negativa de cobertura do tratamento e do fornecimento do medicamento indicado pelo profissional médico deve ser considerada, além de ilegítima, como evento apto a ensejar a violação à esfera jurídica extrapatrimonial do consumidor. 6.1. No caso específico examinado, a conduta da ré não pode ser valorada como mero descumprimento contratual, circunstância que, em regra, pré-exclui a ocorrência de danos morais. Precedentes. 6.2. Isso porque o quadro de saúde da paciente é grave e apresentava piora progressiva, sem que tenham surtido efeitos os fármacos anteriormente indicados. 6.3. Nesses casos, prevalece o**

> **entendimento jurisprudencial de que o dano moral é presumido. 6.4. O valor da compensação financeira em virtude do dano moral sofrido obedece ao critério bifásico consagrado na jurisprudência pátria e deve, ainda, observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.** 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1193146, 07352496920188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso em tela a parte promovente grávida, é portadora de trombofilia com risco de abortamento e prematuridade, necessitando da medicação solicitada para manutenção da gravidez. Também é certo que o profissional que atestou a enfermidade da autora e prescreveu o medicamento em questão possui formação acadêmica necessária, descabendo, no âmbito do Poder Judiciário, discutir-se o conteúdo de tal prescrição médica e de sua efetiva necessidade.

A parte promovida ainda alega superação do entendimento de que o rol da ANS de ser meramente taxativo. Tal alegação não se aplica ao caso concreto, posto que para haver a obrigação do plano de saúde fornecer o fármaco, basta a cobertura do plano e registro na ANVISA.

A enoxaparina sódica é fármaco registrado na ANVISA[1], a alegação de superação do entendimento de que o rol da ANS de ser meramente taxativo não se aplica ao caso em comento. O julgamento da presente ação não se confunde nem conflita com os seguintes entendimentos abaixo, consolidados na Jurisprudência:

> É legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei nº 9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da Lei nº 6.360/76 e 10, V, da Lei nº 6.437/76. Porém, **<u>após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário</u>**. STJ. 2ª Seção. REsp 1726563/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 08/11/2018 **(recurso repetitivo). GRIFADO NESTE**
>
> Enunciado nº. 6 da I Jornada de Direito da Saúde:
>
> > *A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar o fornecimento de medicamentos ainda não registrados na ANVISA, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei.*
>
> Enunciado 26 da I Jornada de Direito da Saúde:

> *É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental.*

Observa-se que a jurisprudência é tranquila quanto ao fornecimento de medicamento devidamente registrado na ANVISA, o que subsume perfeitamente ao caso em julgamento, não havendo fundamento e/ou justificativa que legitima a negativa do plano de saúde em fornecer o medicamento.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais, em especial do Tribunal de Justiça da Paraíba, interpreta o direito constitucional à saúde em sua máxima amplitude, concedendo significado extremamente abrangente aos conceitos de universalidade e integralidade. Nesse sentido, a comprovação da necessidade médica por laudo vincula automaticamente à concessão do tratamento, inclusive pelo Estado, sem a observação de outros requisitos. Por coerência e respeito aos princípios da segurança jurídica e integridade do ordenamento, seguindo os precedentes do Tribunal de Justiça da Paraíba, adoto seu entendimento ampliativo.

Isto posto, reconheço a responsabilidade do plano de saúde em fornecer a medicação indicada por laudo médico a fim de manter hígida a gravidez da parte promovente.

3. Dispositivo.

Ante todo o exposto, **JULGO PROCEDENTE** o pedido da parte promovente para condenar UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO à obrigação de fornecer o medicamento *enoxaparina 40mg* à parte autora **KARLA SUYLLA TRAVASSOS GUEDES**, durante toda a gravidez e puerpério, conforme laudo juntado à inicial, consolidando em definitivos os efeitos da tutela de urgência de urgência, em todos os seus termos, inclusive multa diária;

Por conseguinte, **EXTINGO** o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Processo isento de verbas sucumbenciais nesta fase processual (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

Sentença publicada e registrada automaticamente. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, se não houver outros requerimentos, arquive-se.

Hermeson Alves Nogueira

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: HERMESON ALVES NOGUEIRA
23/11/2020 12:36:01
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 36673273

20112312360139400000003

IMPRIMIR GERAR PDF